Hjelp! Petter må bestå helsefag eksamen!!

Han trenger ekstra cash til en skikkelig klokke!!

HEA3103 Øvingssamling

Offisielle Udir-sett og ekstra øvingscaser. Eksempelsvar som vanlig eksamenstekst, med sikte på et nivå mellom karakter 4 og 5 (uoffisielt, ingen karaktergaranti).

Høst 2023

Oppgave 1 og 2 (begge skal besvares)

Case / situasjon

Sted: Åssiden velferdssenter, skjermet demensavdeling (8 pasienter)

Pasient: Knut Knutsen, f. 10.01.1938 (85 år), ugift. Pårørende: niese Kari.

Diagnoser: Alzheimers sykdom; diabetes type 2 (høyt fastende blodsukker om morgenen).

Medisiner: Blodsukkerregulerende tabletter.

Avdelingens mål: Pasientene skal delta i hverdagslige oppgaver for livskvalitet og mestring. Sansehage og aktivitetstilbud.

Fra pasientjournal:

- Personlig hygiene: trenger veiledning.
- Eliminasjon: kontinent, men blir urolig ved toalettbehov – trenger påminning og hjelp.
- Søvn/hvile: vandrer en del om natten. Sengealarm.
- Hørsel: nedsatt, bruker høreapparat. Forstår ikke alltid det som sies. Liker å snakke om gamle dager.
- Ernæring: god matlyst, glad i kaker/søtsaker (niesen tar med søtsaker ukentlig), litt overvektig.
- Psykososialt: tidvis deprimert, apatisk og tiltaksløs. Blir i godt humør av sang, musikk og samtaler om gamle dager.
- Fysisk: aktiv, går uten hjelpemidler, glad i tur og sansehage.
- Samarbeid: lege, sykepleier, fysio, ergo, frivillige.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen og pasientjournalen til Knut. Lag en tiltaksplan for denne dagen som beskriver hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

I denne tiltaksplanen beskriver jeg hvordan jeg vil hjelpe Knut Knutsen (85) gjennom én dag på den skjermede demensavdelingen ved Åssiden velferdssenter. Knut har Alzheimers sykdom og diabetes type 2 med høyt fastende

blodsukker om morgenen. Han hører dårlig og forstår ikke alltid det som blir sagt, men han er fysisk aktiv og blir glad av sang, musikk og samtaler om gamle dager. Avdelingens mål er at pasientene skal delta i hverdagslige oppgaver for å oppleve livskvalitet og mestring. Målet mitt for dagen er at Knut skal få trygg hjelp med stell, mat og toalett, at blodsukkeret følges opp, og at han får oppleve glede og mestring.

Hoveddel

Dagen starter med god kommunikasjon. Før jeg sier noe annet, sjekker jeg at høreapparatet sitter riktig og virker. Jeg står foran Knut, får blikkontakt og bruker korte, tydelige setninger. Jeg spør om han har hørt meg i stedet for å ta det for gitt. Dette gjør jeg fordi misforståelser lett skaper uro hos en person med Alzheimer, og fordi han har rett til å forstå og være med å bestemme etter pasient- og brukerrettighetsloven.

I morgenstellet veileder jeg i stedet for å overta. Jeg legger fram det han trenger, gir én beskjed om gangen og viser med hendene hvis ordene ikke når fram. Jeg lar ham velge, for eksempel hvilken skjorte han vil ha på. Underveis ser jeg på huden og hvordan han virker i dag. Når Knut får gjøre mest mulig selv, beholder han ferdigheter lenger og føler seg mindre hjelpeløs.

Før frokost måler jeg fastende blodsukker etter avdelingens prosedyre og dokumenterer verdien. Journalen sier at verdiene er høye om morgenen, og det er sykepleier og lege som vurderer medisinene ut fra målingene. Høyt eller lavt blodsukker kan også gi uro og forvirring som lett blir tolket som demens, så verdien hjelper oss å forstå Knut. Til frokost legger jeg til rette for grovt brød og pålegg med lite sukker, og jeg tilbyr drikke. Knut har god matlyst, er litt overvektig og er glad i søtsaker som niesen Kari tar med. Jeg forbyr ingenting, men foreslår at søtsakene kan nytes til kaffen på et fast tidspunkt. Med Knuts samtykke kan sykepleier snakke med Kari om dette, slik at hun blir en samarbeidspartner og ikke føler seg kritisert.

Knut er kontinent, men blir urolig når han må på toalettet. Derfor minner jeg ham på toalettbesøk etter måltider og før aktiviteter, og når jeg ser at han blir rastløs, følger jeg ham rolig dit. Slik forebygger jeg uhell og unngår at uro blir misforstått.

Senere på dagen legger jeg til rette for sang eller samtale om gamle dager, og en tur i sansehagen hvis været tillater det. Journalen sier at dette gir godt humør, og han er tidvis deprimert og tiltaksløs. Aktivitet og dagslys kan også bidra til bedre søvn, siden han vandrer om natten. Jeg dokumenterer blodsukker, mat og drikke, toalett, humør og aktivitet, og gir muntlig rapport til sykepleier. Det er en plikt etter helsepersonelloven, og det gjør at nattevakten og neste vakt kan bygge videre på det som fungerte.

Om kvelden vurderer jeg hvordan dagen gikk. Virket Knut trygg og forsto han beskjedene? Var blodsukkeret innenfor det sykepleier har satt som mål? Gikk dagen uten toalettuhell, og var humøret bedre etter aktiviteten? Hvis noe ikke fungerte, melder jeg det, slik at planen kan justeres i samarbeid med sykepleier, lege, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på opplysningene i Knuts journal. Jeg har lagt vekt på kommunikasjon tilpasset hørsel og demens, veiledning som gir mestring, oppfølging av blodsukkeret og aktiviteter han liker. Som helsefagarbeider observerer, gjennomfører og rapporterer jeg, mens sykepleier og lege tar de medisinske vurderingene. Slik følger planen avdelingens mål og sikrer forsvarlig omsorg.

Oppgave 2

Du skal denne dagen gjennomføre minst én aktivitet sammen med Knut. Målet med aktiviteten skal være at Knut opplever livskvalitet og mestring. Begrunn hvorfor du valgte denne aktiviteten, og reflekter over valget ditt i lys av målet med aktiviteten.

Eksempelsvar

Innledning

I denne oppgaven skal jeg gjennomføre en aktivitet sammen med Knut Knutsen (85) på den skjermede demensavdelingen. Målet er at Knut skal oppleve livskvalitet og mestring. Livskvalitet forstår jeg her som glede, trygghet og tilhørighet, mens mestring betyr at han får bruke ressurser han fortsatt har. Jeg velger en sangstund med kjente sanger fra Knuts ungdom, og etterpå en kort tur i sansehagen hvis han vil og formen tillater det.

Hoveddel

Før vi starter, sjekker jeg om tidspunktet passer. Knut vandrer om natten, så jeg ser i rapporten fra nattevakten og merker meg hvordan han virker etter frokost. Jeg passer på at han har vært på toalettet, fordi han blir urolig når han trenger det. Da unngår jeg at uro som egentlig handler om toalettbehov, ødelegger aktiviteten. Jeg sjekker også at høreapparatet virker, ellers får han verken med seg sangen eller det jeg sier.

Vi sitter et rolig sted uten bakgrunnsstøy, og jeg sitter foran ham slik at han ser ansiktet mitt. Jeg gir ham to valg, for eksempel om han vil synge eller høre på musikk. Å velge mellom to ting er lettere enn åpne spørsmål ved Alzheimer, og det gir ham medvirkning slik pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til. Hvis niesen Kari vet hvilke sanger han liker, bruker jeg det. Jeg retter ikke på ham hvis han glemmer ord, og mellom sangene spør jeg hvor han hørte sangen før, slik at det blir samtale om gamle dager.

Jeg valgte denne aktiviteten fordi journalen sier at Knut blir i godt humør av sang, musikk og samtaler om gamle dager, mens han ellers tidvis er deprimert og tiltaksløs. Ved Alzheimer svekkes evnen til å lære nytt, mens gamle minner og innlærte ferdigheter som å synge kjente sanger ofte holder seg lenger. Når han klarer å synge med, opplever han at han fortsatt kan noe. Det gir mestring og styrker selvfølelsen. At han blir møtt med sanger fra sitt eget liv, viser også at han blir sett som person.

Turen i sansehagen gir lys, frisk luft og bevegelse. Knut går uten hjelpemidler og liker tur, så dette bygger på en ressurs. Dagslys og aktivitet kan gi bedre døgnrytme, men det kan jeg ikke love ut fra én tur. Fordi han har diabetes, ser jeg etter tegn som uvanlig blekhet, svette, skjelving eller økt forvirring. Da avbryter jeg og melder fra til sykepleier.

Underveis observerer jeg om han smiler, synger med og tar initiativ, eller om han blir urolig og trekker seg unna. Han har rett til å si nei, og jeg presser ham ikke. Samtidig vet jeg at tiltaksløshet kan være en del av depresjonen, så jeg kan prøve forsiktig med én sang eller prøve igjen senere. Etterpå dokumenterer jeg hva vi gjorde, hvordan han reagerte og hvilke sanger som fungerte, og jeg gir rapport til sykepleier. Hvis sangstunden gir godt humør flere ganger, kan jeg foreslå at den blir et fast tilbud, gjerne med hjelp fra frivillige.

Avslutning

Sangstunden og turen bygger på Knuts egne interesser og ressurser, og de tar hensyn til demens, hørsel og humør. Han får være med å bestemme, bruke ferdigheter han har og oppleve glede sammen med andre. Gjennom observasjon

og dokumentasjon kan aktiviteten vurderes og videreføres. Slik bidrar den til både livskvalitet og mestring.

Vår 2024

Oppgave 1 ca. 50 %, 2a ca. 30 %, 2b ca. 20 %

Case / situasjon

Sted: Hjemmesykepleien

Pasient: Per Larsen, f. 21.08.1945, ugift. Pårørende: bror i Oslo. Bor i Bergen.

Diagnoser: Hjertesvikt etter hjerteinfarkt i 2021.

Medisiner: Betablokkere, blodfortynnende, kolesterolsenkende.

Arbeidsoppdrag:

- Ca. kl. 09: hjelp til støttestrømper + veiledning/tilrettelegging frokost og lunsj.
- Ca. kl. 13: gå tur sammen med Per.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: klarer selv.
- Sirkulasjon: trenger hjelp til støttestrømper.
- Ernæring: overvektig, glad i sjokolade, lite motivert for å lage mat.
- Psykososialt: deprimert, lite motivert for aktivitet, ensom, lite nettverk.
- Fysisk: lite aktiv. Bruker rullator.
- Samarbeid: fastlege, fysioterapeut, hjemmehjelp hver 3. uke.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, pasientjournalen og arbeidsoppdrag 1. Lag en tiltaksplan for Per. Beskriv hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Denne tiltaksplanen gjelder arbeidsoppdrag 1 hos Per Larsen i hjemmesykepleien i Bergen, ca. kl. 09. Jeg skal hjelpe ham med støttestrømper og veilede og tilrettelegge for frokost og lunsj. Per har hjertesvikt etter et hjerteinfarkt i 2021 og bruker betablokkere, blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner. Han er overvektig, glad i sjokolade og lite motivert for å lage mat. Han er også deprimert, ensom og lite aktiv. Målet er at Per får støttestrømpene riktig på, at han spiser et sunnere måltid som han selv har vært med å velge, og at jeg følger med på tegn til forverring.

Hoveddel

Når jeg kommer, hilser jeg og forteller kort hva vi skal gjøre. Jeg spør hvordan natten har vært og hvordan han har det i dag. Det viser respekt for at jeg er i hjemmet hans, og det gir meg samtidig viktige opplysninger. Ved hjertesvikt er det viktig å legge merke til om han er mer tungpustet enn vanlig, om han har sovet dårlig fordi han ikke får puste når han ligger flatt, og om bena er mer hovne.

Før jeg tar på støttestrømpene, ser jeg på bena. Jeg observerer hevelse, hudfarge, tørr hud og sår. Hvis hevelsen er tydelig økt eller jeg ser sår, melder jeg det til sykepleier før strømpene tas på, fordi det kan være tegn på at hjertesvikten forverres. Jeg bruker riktig teknikk eller påtrekkshjelpemiddel og sørger for at strømpene sitter glatt uten folder. Støttestrømper hjelper blodet tilbake fra bena og kan redusere hevelse, men folder kan gi trykk og sår, og huden til eldre er skjør. Blodfortynnende medisin gjør også at blåmerker og sår kan bli større.

Deretter snakker vi om frokost og lunsj. Jeg spør hva Per liker og hva han har i huset. Jeg foreslår enkle valg som grovt brød, magert pålegg, egg, fisk og frukt eller grønnsaker, og jeg kan smøre lunsjen sammen med ham og sette den i kjøleskapet. Jeg forteller kort at mindre salt og mettet fett er bra for hjertet, og at det å spise jevnlig kan gjøre det lettere å la sjokoladen ligge. Jeg moraliserer ikke og forbyr ikke sjokolade, men vi kan bli enige om at den kan være en kos på et fast tidspunkt. Når Per er med å bestemme, er sjansen større for at han følger rådene. Det er også medvirkning slik pasient- og brukerrettighetsloven beskriver.

Per er deprimert og ensom, og det påvirker både matlyst og egenomsorg. Derfor tar jeg meg tid til en kort samtale mens vi lager maten. Kanskje kan vi snakke om turen vi skal gå kl. 13, slik at han har noe å se fram til.

Til slutt dokumenterer jeg tilstanden på bena, hvordan han har det, hva han spiste og hva vi ble enige om. Endringer som økt hevelse, tungpust eller tegn på at han ikke tar medisinene, melder jeg til sykepleier. Helsepersonelloven krever at jeg dokumenterer, og det er sykepleier og fastlege som vurderer behandlingen.

Jeg evaluerer ved å se om strømpene sitter godt og ikke gir sår, om Per spiste maten vi lagde, og om han virket mer positiv. Over tid kan vekt og hevelse si noe om tiltakene virker.

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på Pers diagnose og journal. Den kombinerer praktisk hjelp med støttestrømper, observasjon av tegn på forverret hjertesvikt, kostveiledning der Per er med å bestemme, og oppmerksomhet på at han er deprimert og ensom. Jeg holder meg innenfor det helsefagarbeideren skal gjøre, og jeg samarbeider med sykepleier og fastlege.

Oppgave 2a

Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, pasientjournalen og arbeidsoppdrag 2. Lag en tiltaksplan med faglige begrunnelser for arbeidsoppdrag 2. Målet er å fremme livskvalitet og mestring.

Eksempelsvar

Innledning

Arbeidsoppdrag 2 er å gå tur med Per ca. kl. 13. Per har hjertesvikt, bruker rullator og er lite aktiv. Han er også deprimert, ensom og har lite nettverk. Målet med tiltaksplanen er å fremme livskvalitet og mestring. Turen skal være trygg for hjertet, og den skal være noe Per opplever som positivt, slik at han får lyst til å gå igjen.

Hoveddel

Jeg planlegger turen sammen med Per. Jeg spør hvor han liker å gå, og vi avtaler en kort og flat rute med steder der han kan hvile, for eksempel en benk. Vi kan gjerne gå til et sted han har et forhold til. Jeg sjekker at rullatoren er i orden, at han har gode sko og klær etter været, og at han har drukket og spist. Når Per er med å bestemme, får han eierskap til turen. Det øker motivasjonen hos en som ellers har lite lyst til aktivitet.

Før vi går, spør jeg hvordan han har det, og jeg ser etter tungpust eller hevelse i bena. Hvis han er tydelig dårligere enn vanlig, utsetter jeg turen og melder fra til sykepleier. Under turen går jeg ved siden av ham i hans tempo. En god regel er at han skal klare å snakke mens han går. Jeg observerer pust, hudfarge, svette og om han blir sliten eller svimmel, og vi tar pause før han blir utmattet. Ved hjertesvikt tåler hjertet lett aktivitet, og det kan gi bedre kondisjon, søvn og humør, men for mye belastning kan være farlig. Betablokkere gjør at pulsen ikke alltid stiger slik vi forventer, så jeg ser mer på hvordan han puster og har det.

Turen er også et sosialt tiltak. Jeg prater med Per om ting han er opptatt av, og jeg gir ham ros for det han klarer, for eksempel at han gikk litt lenger enn sist. Han er ensom, og en hyggelig samtale kan bety like mye for livskvaliteten som selve gangen. Fysisk aktivitet kan også dempe depressive plager. Hvis han har lyst, kan vi snakke om andre muligheter for å komme seg ut, som et dagsenter eller en turgruppe. Det vil i så fall være noe jeg tar opp med sykepleier.

Etter turen spør jeg hvordan han opplevde den, og jeg ser at han hviler og får drikke. Jeg dokumenterer hvor langt og lenge vi gikk, hva jeg observerte og hva Per selv sa. Dokumentasjonen gjør at fysioterapeuten og kollegene kan bygge videre, og at turene kan økes gradvis hvis det går bra.

Jeg evaluerer ved å se om Per klarte turen uten tegn til forverring, og om han sier at han vil gå igjen. Over flere uker kan vi se om han orker mer, og om humøret blir bedre.

Avslutning

Tiltaksplanen kobler fysisk aktivitet til Pers psykiske og sosiale behov. Han er med å planlegge, turen er tilpasset hjertesvikten, og jeg observerer ham hele tiden. Slik kan turen gi både mestring og livskvalitet uten å sette helsen hans i fare.

Oppgave 2b

Per og du går tur. Du observerer etter hvert at han går saktere, blir mer stille og er blek. Per sier han føler seg svimmel. Han greier ikke å stå på bena lenger. Beskriv hva du gjør, og begrunn valgene dine faglig.

Eksempelsvar

Innledning

Under turen endrer Pers tilstand seg. Han går saktere, blir stille og blek, sier at han er svimmel, og til slutt klarer han ikke å stå. Per har hjertesvikt etter hjerteinfarkt og bruker blodfortynnende medisin. Dette kan være en akutt og alvorlig situasjon, og jeg må handle raskt, rolig og forsvarlig.

Hoveddel

Det første jeg gjør, er å stoppe turen og hindre at han faller. Jeg støtter ham og hjelper ham ned, helst på rullatorsetet, en benk eller bakken. Et fall kan gi brudd eller hodeskade, og fordi han bruker blodfortynnende, er det større fare for blødning. Hvis han føler seg svimmel og blek, kan det hjelpe å legge ham ned og eventuelt heve bena, så lenge han ikke blir mer tungpustet av det. Hvis han får tungt for å puste, er det bedre at han sitter.

Deretter vurderer jeg ham raskt. Jeg sjekker om han er våken og svarer, om han puster normalt, og om huden er kald og klam. Jeg spør om han har smerter i brystet, armen eller kjeven, om han er kvalm eller tungpustet. Brystsmerter,

kald svette og tungpust kan være tegn på nytt hjerteinfarkt. Svimmelhet og blekhet kan også skyldes lavt blodtrykk eller forstyrrelser i hjerterytmen, som Per har økt risiko for.

Fordi symptomene er alvorlige og han ikke klarer å stå, ringer jeg 113. Jeg sier hvor vi er, hva som har skjedd og hva jeg observerer, og jeg følger rådene fra operatøren. Jeg blir hos Per hele tiden, snakker rolig til ham og holder ham varm. Hvis han slutter å puste normalt, starter jeg hjerte-lunge-redning etter det jeg har lært. Så snart det er mulig, varsler jeg sykepleier i hjemmesykepleien, slik at de vet hva som skjer og kan varsle videre.

Jeg skal ikke prøve å få Per hjem selv, og jeg skal ikke vente for å se om det går over. Som helsefagarbeider er det ikke min oppgave å stille diagnose, men jeg skal kjenne igjen tegn på at noe er alvorlig og sørge for at riktig hjelp kommer fort. Helsepersonelloven krever at jeg gir forsvarlig hjelp og øyeblikkelig hjelp når det er nødvendig.

Etterpå dokumenterer jeg tidspunkt, hva jeg observerte, hva jeg gjorde og hvem jeg varslet. Det er viktig for videre behandling og for å lære av hendelsen. Jeg kan også tenke gjennom om turen var for lang, og om aktivitetene må vurderes på nytt sammen med sykepleier og fastlege.

Avslutning

I denne situasjonen er det viktigste å forhindre fall, observere tegn på alvorlig sykdom, ringe 113 og bli hos Per. Jeg handler raskt fordi han har kjent hjertesykdom, og fordi symptomene kan være tegn på et nytt infarkt eller annen akutt svikt.

Høst 2024

Oppgave 1 ca. 50 %, oppgave 2 ca. 50 %

Case / situasjon

Sted: Hjemmesykepleien (morgen og kveld)

Pasient: Eva Larsen, f. 19.02.1939, enke. To døtre. Adresse Dalen.

Bakgrunn: Ny pasient. Hjem etter korttidsopphold på sykehjem pga. urinveisinfeksjon, forvirring og flere fall. Pårørende bekymret for hygiene og lite mat/drikke. Eva liker ikke hjelp og vil klare seg selv.

Diagnoser: Tilbakevendende/hyppig urinveisinfeksjon.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: vil klare selv; pårørende bekymret for kroppslukt, ønsker veiledning.
- Ernæring: underernært, lite motivert for matlaging, 1–2 glass vin daglig.
- Psykososialt: lange dager, ensom, lite nettverk, regelmessig besøk av døtrene.
- Fysisk: beveger seg normalt, men kan være ustødig. Trygghetsalarm.
- Samarbeid: fastlege, ergoterapeut, hjemmehjelp hver 3. uke.
- Kommunikasjon: liker å prate.

Oppgave 1

Eva liker ikke å ta imot hjelp fra hjemmesykepleien og er bestemt på å klare seg selv. Beskriv hvordan du går fram for å gi Eva nødvendig helsehjelp. Begrunn svaret. Viktige momenter: pasient- og brukermedvirkning, kommunikasjon og samhandling.

Eksempelsvar

Innledning

Eva Larsen er ny pasient i hjemmesykepleien. Hun har vært på korttidsopphold på sykehjem etter urinveisinfeksjon, forvirring og flere fall, og hun har tilbakevendende urinveisinfeksjoner. Døtrene er bekymret for hygienen og for at hun spiser og drikker lite. Eva liker ikke hjelp og vil klare seg selv. Oppgaven min er å gi henne nødvendig helsehjelp på en måte som respekterer at hun vil bestemme selv, samtidig som jeg tar risikoen på alvor.

Hoveddel

Det første jeg gjør, er å bygge en relasjon. Jeg ringer på, presenterer meg og forklarer hvorfor jeg kommer. Jeg spør om jeg kan komme inn, fordi jeg er gjest i hjemmet hennes. Eva liker å prate, og det bruker jeg. Jeg lar henne fortelle om livet sitt og hvordan dagene er. Jeg lytter aktivt og viser at jeg forstår at det er viktig for henne å klare seg selv. Når hun føler seg hørt, er det lettere for henne å stole på meg.

Deretter forklarer jeg ærlig og enkelt hvorfor hjemmesykepleien kommer. Jeg kan si at hun har vært gjennom en tøff tid med infeksjon og fall, og at målet er at hun skal klare seg trygt hjemme lengst mulig. Jeg unngår å skremme henne eller snakke ned til henne. Jeg legger vekt på at hjelpen skal støtte det hun klarer selv, ikke ta over.

Så tilbyr jeg hjelp i små steg og gir henne reelle valg. Kanskje er det lettere for henne å si ja til at vi drikker en kopp kaffe og spiser litt sammen enn til hjelp med dusjen. Jeg spør hva hun synes er vanskelig, og hva hun ønsker hjelp til. Pasient- og brukerrettighetsloven gir Eva rett til å medvirke og til å takke nei til helsehjelp når hun er samtykkekompetent. Hvis hun er forvirret, kan samtykkekompetansen svinge, og da må jeg melde det til sykepleier. Det er ikke min oppgave å vurdere samtykkekompetanse alene.

Underveis observerer jeg diskré. Jeg ser etter om hun er forvirret, om hun er ustødig, om det er lukt som kan tyde på urinlekkasje, og om det finnes mat i kjøleskapet. Ny forvirring kan være tegn på en ny urinveisinfeksjon. Dette dokumenterer jeg og melder til sykepleier.

Døtrene er viktige for Eva og besøker henne ofte. Jeg spør Eva om hun vil at de skal få informasjon og være med i samarbeidet. Uten samtykke har jeg taushetsplikt etter helsepersonelloven. Med samtykke kan døtrene bli en støtte, for eksempel ved å spise sammen med henne når de er på besøk. Jeg samhandler også med sykepleier, fastlege, ergoterapeut og hjemmehjelpen, slik at alle gir like råd og ikke overkjører Eva.

Jeg velger denne framgangsmåten fordi press og tvang kan gjøre at Eva sier nei til all hjelp. Da blir risikoen for nye fall, infeksjoner og underernæring større. Tillit er derfor en forutsetning for å gi forsvarlig helsehjelp.

Avslutning

For å hjelpe Eva går jeg veien om relasjon, ærlig kommunikasjon og medvirkning. Jeg respekterer at hun vil klare seg selv, observerer tegn på risiko og samarbeider med døtrene og andre fagfolk når hun samtykker. Slik øker sjansen for at hun etter hvert tar imot den hjelpen hun trenger.

Oppgave 2

Ut fra tiltakene du har beskrevet i oppgave 1, bestemmer Eva seg for å ta imot hjelp. Skriv en tiltaksplan for Eva der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du vil gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Eva har nå sagt ja til hjelp fra hjemmesykepleien morgen og kveld. Hun har tilbakevendende urinveisinfeksjoner, er underernært, drikker 1–2 glass vin daglig, kan være ustødig og har falt flere ganger. Hun er ensom og har lange dager, men liker å prate og får besøk av døtrene. Målet med tiltaksplanen er at Eva skal få hjelp til hygiene, mat og drikke og fallforebygging, slik at risikoen for ny infeksjon, fall og vekttap blir mindre, samtidig som hun beholder verdighet og mestring.

Hoveddel

Om morgenen veileder jeg Eva i personlig hygiene. Jeg lar henne gjøre det hun klarer, og jeg er der for å støtte, ikke for å ta over. Jeg sørger for god belysning, sklimatte og at hun kan sitte på en stol i dusjen hvis hun er ustødig. Jeg gir diskré råd om intimhygiene, for eksempel å vaske og tørke forfra og bakover og skifte undertøy daglig. Det er viktig for å forebygge urinveisinfeksjon. Jeg observerer huden og ser etter tegn på urinlekkasje. Fordi døtrene har vært bekymret for lukt, er det viktig at dette gjøres på en måte som ikke krenker Eva.

Når det gjelder mat og drikke, spør jeg Eva hva hun liker, og vi lager frokost sammen. Jeg tilbyr små og næringsrike måltider, for eksempel egg, ost, yoghurt og grovbrød med godt pålegg. Jeg setter fram drikke og oppfordrer henne til å drikke jevnt gjennom dagen. Nok væske skyller urinveiene og reduserer faren for ny infeksjon. Om kvelden kan jeg sette fram et lite kveldsmåltid. Jeg snakker forsiktig med henne om vinen og forklarer at alkohol kan øke faren for fall og gi mindre matlyst. Jeg moraliserer ikke, men gir henne kunnskap til å velge selv. Hvis hun fortsetter å gå ned i vekt, melder jeg det til sykepleier, som kan vurdere næringsdrikk sammen med fastlegen. Jeg kan også følge med på vekten etter avtale.

For å forebygge fall ser jeg sammen med Eva på hjemmet. Vi ser etter løse tepper, ledninger og dårlig lys, og jeg sjekker at hun har gode sko. Jeg minner henne på å ha trygghetsalarmen på seg. Hvis det trengs hjelpemidler, melder jeg til sykepleier, som kan kontakte ergoterapeuten.

Underveis observerer jeg tegn på urinveisinfeksjon, som svie, hyppig vannlating, feber eller at hun blir forvirret. Hos eldre kan forvirring være det første tegnet, slik det var hos Eva før. Jeg melder slike tegn til sykepleier med en gang.

Eva er ensom, så jeg tar meg tid til å prate under besøkene. Hvis hun ønsker det, kan vi snakke om aktiviteter eller frivillige tilbud, og med hennes samtykke kan døtrene være med å spise sammen med henne når de er der. Sosial kontakt kan gi bedre matlyst og livsglede.

Alt dokumenterer jeg i journalen. Jeg evaluerer etter noen uker sammen med sykepleier: Spiser og drikker Eva mer, holder vekten seg, har hun unngått nye fall og infeksjoner, og føler hun at hjelpen respekterer henne?

Avslutning

Tiltaksplanen bygger på tilliten fra første møte og på det journalen sier om Eva. Hun får hjelp til hygiene, ernæring og fallforebygging, samtidig som hun får bestemme og gjøre mest mulig selv. Jeg observerer og rapporterer endringer, og samarbeider med sykepleier, fastlege, ergoterapeut og døtrene.

Vår 2025

Oppgave 1 ca. 60 %, oppgave 2 ca. 40 %

Case / situasjon

Sted: Demensavdeling, Solsiden sykehjem, Tromsø

Pasient: Anne Larsen, f. 10.02.1946, gift. Pårørende: ektefelle og datter i nærheten.

Diagnoser: Demens. Nedsatt hørsel (høreapparat).

Utfordringer: Blir lett forvirret og sint ved ting hun ikke forstår. Kan utagere fysisk/verbalt og opptre truende. Urolig, vandrer mye.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: klarer selv med veiledning.
- Fysisk: liker tur og sansehage.
- Psykisk: trenger ro og trygge omgivelser.
- Sosialt: liker aktiviteter på avdelingen.
- Åndelig: glad i naturen.
- Kommunikasjon: sint ved mange spørsmål/krav; vansker med å forstå og finne ord.
- Ernæring: liker å smøre maten selv, deltar i felles måltider, drikker lite.

Oppgave 1

Du skal veilede Anne i personlig hygiene og tilrettelegge for frokost. Lag en tiltaksplan der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor du velger å gjøre det slik.

Eksempelsvar

Innledning

Anne Larsen bor på demensavdelingen ved Solsiden sykehjem. Hun har demens og nedsatt hørsel, og hun blir lett forvirret og sint når hun ikke forstår. Hun kan utagere og vandrer mye. Hun klarer hygiene selv med veiledning, liker å smøre maten selv og deltar i felles måltider, men drikker lite. Jeg skal veilede henne i personlig hygiene og tilrettelegge for frokost. Målet er at Anne gjør mest mulig selv, at morgenen blir rolig og trygg, og at hun får i seg mat og drikke.

Hoveddel

Jeg forbereder meg før jeg går inn til Anne. Jeg leser rapporten fra natten for å vite om hun har sovet og hvordan hun har det. Jeg legger fram håndkle, toalettsaker og klær, slik at stellet kan skje uten at jeg må lete. Når jeg går inn, banker jeg på, sier navnet mitt og møter henne rolig og vennlig. Jeg sjekker at høreapparatet sitter og virker.

Journalen sier at Anne blir sint av mange spørsmål og krav, og at hun har vansker med å forstå og finne ord. Derfor bruker jeg korte setninger, én beskjed om gangen, og jeg viser mer enn jeg forklarer. Jeg kan for eksempel gi henne vaskekluten og vise at hun kan vaske ansiktet. Jeg lar henne gjøre det hun klarer, og jeg hjelper bare der det trengs.

Jeg gir henne enkle valg, som mellom to gensere. Slik får hun medvirke uten å bli overveldet. Hvis hun blir sint eller sier nei, diskuterer jeg ikke. Jeg trekker meg litt tilbake, avleder med noe hun liker, og prøver igjen senere. Det er bedre å utsette stellet enn å skape en situasjon der hun blir redd og utagerer.

Underveis observerer jeg hud, humør og om hun virker å ha vondt. Fordi hun drikker lite, ser jeg også etter tegn på urinveisinfeksjon, som økt forvirring eller uro, og melder det til sykepleier.

Til frokost følger jeg henne til fellesbordet, fordi hun liker å delta i felles måltider. Jeg velger en rolig plass med lite støy, slik at hun hører og ikke blir stresset. Jeg setter fram brød og pålegg og lar henne smøre maten selv. Det gir mestring og selvfølelse. Jeg setter et glass med noe hun liker å drikke foran henne og minner henne vennlig på å drikke. Jeg kan gjerne drikke sammen med henne, fordi personer med demens ofte gjør det andre gjør. Nok væske forebygger forvirring, forstoppelse og urinveisinfeksjon.

Etterpå dokumenterer jeg hvordan stellet gikk, hva som fungerte, hva hun spiste og hvor mye hun drakk. Jeg gir rapport til sykepleier. Helsepersonelloven krever dokumentasjon, og den hjelper kollegene til å møte Anne på samme måte, noe som gir henne trygghet.

Jeg evaluerer morgenen ved å se om stellet og frokosten gikk uten at hun ble sint, om hun gjorde mye selv, og om hun drakk nok. Hvis det ofte blir konflikter, tar jeg det opp med sykepleier, og vi kan spørre ektefellen eller datteren om hvilke vaner hun hadde før.

Avslutning

Tiltaksplanen er bygget rundt Annes behov for ro og trygghet. Jeg bruker enkel kommunikasjon, lar henne gjøre mest mulig selv og unngår press. Ved frokosten bygger jeg på at hun liker å smøre maten selv og spise sammen med andre, og jeg følger opp at hun drikker lite. Slik får hun hjelp på en måte som bevarer verdigheten.

Oppgave 2

Anne er urolig og vandrer mye. Foreslå aktiviteter ut fra Annes funksjonsnivå og begrunn faglig hvorfor du har valgt disse aktivitetene. Målet er å redusere uro, vandring og forvirring.

Eksempelsvar

Innledning

Anne er urolig og vandrer mye. Hun har demens og nedsatt hørsel, og hun blir forvirret og sint av mange krav og spørsmål. Journalen sier at hun liker tur, sansehage og aktiviteter på avdelingen, og at hun er glad i naturen. Målet er å redusere uro, vandring og forvirring. Jeg vil ikke stoppe vandringen for enhver pris, men finne aktiviteter som møter behovene bak uroen.

Hoveddel

Vandring hos personer med demens kan ha mange årsaker, for eksempel behov for bevegelse, kjedsomhet, smerter, toalettbehov, sult, tørste eller at personen leter etter noe kjent. Derfor starter jeg med å observere når Anne blir urolig. Er det til faste tider på dagen, etter måltider eller når det er mye støy? Fordi hun drikker lite, sjekker jeg også at hun får nok drikke. Hvis uroen er ny eller verre enn vanlig, melder jeg det til sykepleier, fordi det kan skyldes smerter eller infeksjon.

Den første aktiviteten jeg foreslår, er tur i sansehagen eller en kort tur ute. Anne liker tur og natur, og hun er glad i naturen også på et åndelig plan. Når hun får gå sammen med noen i rolige omgivelser, får hun dekket behovet for bevegelse på en trygg måte. Frisk luft og dagslys kan også gi bedre søvn og mindre uro om kvelden. Jeg går ved siden av henne i hennes tempo, peker på blomster eller fugler og sier lite. Naturen kan gi ro uten at hun må svare på spørsmål.

Den andre aktiviteten er enkle hverdagsoppgaver, som å brette håndklær, vanne blomster eller dekke bordet. Slike oppgaver kjenner hun ofte fra før, og de gir en følelse av å være til nytte. Jeg viser hva vi skal gjøre i stedet for å forklare mye, og jeg gjør oppgaven sammen med henne. Det gir mestring og mening, noe som kan dempe uro som kommer av kjedsomhet.

Den tredje aktiviteten er en rolig stund med musikk eller å se på bilder av natur, gjerne én-til-én i et stille rom. Jeg sjekker at høreapparatet virker. Musikk kan gi gode følelser og ro, også når språket er svekket. Hvis datteren eller ektefellen vet hvilken musikk hun liker, bruker jeg det.

I alle aktivitetene møter jeg Anne med ro. Jeg bruker korte setninger, bekrefter følelsene hennes og retter ikke på henne hvis hun sier noe som ikke stemmer. Dette kalles validering, og det gir trygghet. Jeg avbryter hvis hun blir sliten eller overstimulert. Jeg prøver å tilby aktiviteten før uroen blir sterk, fordi det er lettere å forebygge enn å roe henne ned.

Jeg dokumenterer hvilke aktiviteter som fungerte og når på dagen, og gir rapport. Over tid kan vi se om Anne vandrer mindre, virker roligere og sjeldnere blir sint.

Avslutning

Aktivitetene bygger på det Anne liker og klarer: tur og natur, hverdagsoppgaver og rolig musikk. Ved å se på hvorfor hun vandrer og tilby meningsfull aktivitet i stedet for å stoppe henne, kan uro og forvirring bli mindre. Slik blir hverdagen tryggere for Anne.

Høst 2025

Oppgave 1: 60 %, oppgave 2: 20 %, oppgave 3: 20 %

Case / situasjon

Sted: Solsiden sykehjem, rehabiliteringsavdeling (3 uker)

Pasient: Åse Olsen, f. 08.08.1933 (92), enke. To barn, fem barnebarn, ti oldebarn.

Diagnoser: Hoftebrudd (operert etter fall); gjentatte urinveisinfeksjoner.

Status: Motivert for trening, vil hjem fort. Ustødig/svimmel, spiser lite, obstipasjon, gjentatte UVI. Nedsatt hørsel (høreapparat), prekestol.

Fra pasientjournal:

- Hygiene: vil klare mest mulig, trenger tilrettelegging/hjelp.
- Fysisk: trenger trening, ustødig/svimmel, glad i tur.
- Psykisk: motivert for å komme hjem.
- Sosial/åndelig: sosial, opptatt av familie, liker musikk.
- Ernæring: dårlig matlyst, spiser lite.

Egen situasjon i oppgave 2: hjemmesykepleie hos pasient med diabetes type 2; lage lunsj ut fra matvarer på bilde (bildet er ikke gjengitt her – svaret følger vanlige diabetesprinsipper).

Oppgave 1

Hvilke tiltak vil du sette i verk for at Åse skal nå sitt mål om å komme hjem så fort som mulig? Begrunn tiltakene faglig.

Eksempelsvar

Innledning

Åse Olsen er 92 år og er på rehabiliteringsavdelingen ved Solsiden sykehjem i tre uker etter at hun ble operert for hoftebrudd etter et fall. Hun er motivert for å trene og vil hjem fort. Samtidig er hun ustødig og svimmel, spiser lite, har forstoppelse og har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner. Hun hører dårlig og bruker prekestol. Målet er at Åse skal komme hjem så fort som mulig, og da må hun bli sterkere og tryggere, og vi må unngå komplikasjoner som kan forsinke henne.

Hoveddel

Det viktigste tiltaket er trygg trening. Jeg følger planen fra fysioterapeuten og går korte turer med Åse med prekestolen flere ganger om dagen. Hun er glad i tur, så det bygger på noe hun liker. Fordi hun er svimmel, lar jeg henne sitte litt på sengekanten før hun reiser seg, og jeg går tett ved siden av henne. Jeg sørger for gode sko og at gulvet er ryddig. Jeg observerer om hun blir blek, svimmel eller har vondt, og hvis svimmelheten er ny eller verre,

melder jeg til sykepleier. Trening er nødvendig for å få tilbake styrke og gangfunksjon, men et nytt fall kan gi et nytt brudd og stoppe hele rehabiliteringen.

Det andre tiltaket gjelder mat. Åse har dårlig matlyst, men hun trenger protein og energi for at såret skal gro og musklene skal bli sterkere. Jeg spør hva hun liker, tilbyr små måltider ofte og legger til rette for at hun kan spise sammen med andre, fordi hun er sosial. Jeg registrerer hva hun spiser, og hvis inntaket er lite, melder jeg til sykepleier, som kan vurdere næringsdrikk.

Det tredje tiltaket er å forebygge forstoppelse og urinveisinfeksjon. Jeg oppfordrer Åse til å drikke jevnt gjennom dagen og tilbyr mat med fiber, som grovbrød, frukt og grønnsaker. Aktivitet hjelper også magen. Jeg legger til rette for faste toalettrutiner og hjelper henne med intimhygiene der hun trenger det. Forstoppelse gir ubehag og dårligere matlyst, og en ny urinveisinfeksjon kan gi feber, forvirring og økt fallfare. Jeg observerer avføring, urin og tegn som svie, hyppig vannlating eller forvirring, og melder fra.

I stellet lar jeg Åse gjøre mest mulig selv, med hjelp der det trengs. Hun skal klare seg hjemme, så det er viktig å øve på daglige gjøremål som å kle på seg og vaske seg. Jeg sjekker at høreapparatet virker, slik at hun forstår beskjeder og kan være med å planlegge. Hun har rett til medvirkning etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Jeg bruker også motivasjonen hennes. Hun er opptatt av familien og liker musikk. Jeg kan snakke om barnebarna, og jeg viser henne fremgangen hun gjør, for eksempel at hun går lenger enn i går. Med Åses samtykke kan familien være med på planleggingen av hjemreisen.

Alt dokumenterer jeg, og jeg gir rapport til sykepleier. Hver uke kan teamet vurdere om hun går tryggere, spiser mer, har normal avføring og er uten infeksjon.

Avslutning

Tiltakene handler om trening, mat og forebygging av forstoppelse og infeksjon, fordi dette er det som kan hindre Åse i å komme hjem. Jeg bygger på motivasjonen og interessene hennes, observerer og rapporterer, og samarbeider med sykepleier, fysioterapeut og familien. Slik får hun best mulig sjanse til å nå målet sitt.

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i det vedlagte bildet. Foreslå hvilke matvarer pasienten bør velge til lunsj. Er det noen matvarer som ikke er på bildet som du vil foreslå i tillegg? Begrunn valgene. (Situasjon: hjemmesykepleie, pasient med diabetes type 2.)

Eksempelsvar

Innledning

Jeg er i hjemmesykepleien hos en pasient med diabetes type 2 og skal hjelpe til med lunsjen. Bildet fra eksamenssettet er ikke gjengitt i denne samlingen, så jeg svarer ut fra vanlige matvarer og de kostrådene som gjelder ved diabetes type 2. På eksamen må man knytte svaret til matvarene på bildet.

Hoveddel

Først spør jeg pasienten hva han eller hun har lyst på, og hva som er vanlig til lunsj. Det er pasienten som skal spise maten, og når pasienten er med å bestemme, er sjansen større for at rådene blir fulgt. Det er også en rett etter pasient- og brukerrettighetsloven. Jeg spør også når pasienten spiste sist og har tatt medisinene, fordi det påvirker blodsukkeret.

Til lunsj foreslår jeg grovt brød eller knekkebrød. Grove kornprodukter har mye fiber, og fiber gjør at sukkeret tas opp langsommere i blodet. Det gir jevnere blodsukker og holder pasienten mett lenger. På brødet foreslår jeg pålegg med mye protein og lite sukker, som egg, makrell i tomat, kylling, mager ost eller cottage cheese. Fisk er bra for hjertet, og personer med diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdom. Til dette passer grønnsaker som tomat, agurk og paprika. Grønnsaker gir fiber og vitaminer uten å påvirke blodsukkeret mye. Som drikke foreslår jeg vann, kaffe eller te uten sukker, eller et glass lettmelk.

Hvis bildet viser søtt pålegg som syltetøy eller sjokoladepålegg, loff, brus eller kaker, foreslår jeg å begrense dette. Slike matvarer gir raske blodsukkerstigninger. Jeg forbyr ikke noe, men forklarer kort hvorfor andre valg er bedre for blodsukkeret.

Hvis noe mangler, kan jeg foreslå å kjøpe inn grove kornprodukter, mer grønnsaker, fisk til pålegg og en frukt som dessert. Hvis pasienten synes det er vanskelig å lage mat, kan ferdigkuttede grønnsaker og enkle pålegg gjøre det lettere. Jeg kan også ta med meg tankene til sykepleier, som kan vurdere om pasienten trenger mer veiledning eller hjelp til innkjøp.

Jeg observerer om pasienten spiser maten, og om det er tegn på høyt eller lavt blodsukker, som tretthet, tørste, svette eller skjelving. Jeg dokumenterer hva pasienten spiste og eventuelle observasjoner.

Avslutning

Lunsjen jeg foreslår, har mye fiber og protein og lite sukker, og den kan gi jevnere blodsukker og bedre helse. Pasienten er med å velge, og jeg forklarer enkelt hvorfor. Siden bildet ikke er gjengitt her, bygger svaret på generelle diabetesråd.

Oppgave 3

Du skal måle blodsukker etter oppgitt prosedyre. Forklar faglig hvorfor prosedyren skal utføres på denne måten. Begrunn ut fra gjeldende retningslinjer for hygiene og smittevern.

Eksempelsvar

Innledning

Jeg skal måle blodsukker hos en pasient etter oppgitt prosedyre. I denne oppgaven forklarer jeg hvorfor hvert steg i prosedyren skal gjøres slik det står. Jeg legger vekt på hygiene og smittevern, og på at målingen skal gi et riktig svar.

Hoveddel

Prosedyren starter med at pasienten vasker hendene med såpe og vann, og at hendene er tørre. Det fjerner mikrober, slik at det blir mindre fare for infeksjon i stikkstedet. Det fjerner også sukker og matrester fra fingrene, som kan gi et feil høyt svar. Varmt vann gir dessuten bedre blodsirkulasjon, slik at det er lettere å få en bloddråpe.

Jeg utfører håndhygiene og tar på hansker. Basale smittevernrutiner sier at vi skal bruke hansker når vi kan komme i kontakt med blod. Hanskene beskytter meg mot blodsmitte og pasienten mot mikrober fra hendene mine. Håndhygiene før og etter hver pasient hindrer at smitte overføres mellom pasienter.

Før målingen sjekker jeg at blodsukkerapparatet virker og at teststrimlene ikke er gått ut på dato. Utløpte strimler kan gi feil verdi, og hvis verdien er feil, kan pasienten få feil behandling.

Jeg stikker på siden av fingertuppen. Der er det mange blodårer og færre nerveender enn midt på, så det gjør mindre vondt. Vi bytter finger fra gang til gang, slik at huden ikke blir sår og hard. Lansetten skal bare brukes én gang, fordi den kan overføre smitte og blir sløv.

Den første bloddråpen tørker jeg bort, og jeg bruker den andre. Den første dråpen kan inneholde vevsvæske og rester fra huden, som kan gi et feil svar. Jeg presser ikke hardt på fingeren, fordi det også kan presse ut vevsvæske og gi feil verdi.

Etter målingen legger jeg en tørk på stikkstedet. Lansetten kaster jeg med en gang i en gul kanyleboks. Det forebygger stikkskader og blodsmitte hos meg og andre. Brukt utstyr og hansker kastes etter rutinene, og jeg utfører håndhygiene igjen.

Til slutt dokumenterer jeg verdien, tidspunktet og om pasienten hadde spist. Blodsukkerverdien er viktig for sykepleier og lege når de vurderer behandlingen. Hvis verdien er uvanlig høy eller lav, melder jeg fra med en gang. Jeg forklarer også pasienten hva jeg gjør, slik at han eller hun er med og kan lære å måle selv.

Avslutning

Hvert steg i prosedyren har en grunn. Noen steg skal forebygge smitte for både pasient og helsepersonell, og andre skal sikre at svaret blir riktig. Når jeg følger prosedyren nøyaktig, gir jeg forsvarlig helsehjelp slik helsepersonelloven krever.

Øvingscase: Bjørg (hoftebrudd og KOLS)

Øvingscase (én hovedoppgave, ca. oppgave 1-lengde)

Case / situasjon

Sted: Sykehjem / rehabilitering etter hoftebrudd

Pasient: Bjørg, 78 år.

Bakgrunn: Innlagt på sykehjem etter hoftebrudd. Har KOLS, er røyker og har nylig hatt infeksjon i nedre luftveier. Er i gang med rehabilitering, men blir fort andpusten ved mobilisering. Uttrykker bekymring for å falle igjen. Bodde tidligere hjemme med hjemmesykepleie to ganger daglig. Datteren er usikker på om moren kan flytte hjem igjen.

Diagnoser: Hoftebrudd; KOLS; nylig nedre luftveisinfeksjon.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i caset om Bjørg. Lag en tiltaksplan der du beskriver hva du vil gjøre, hvordan du vil gjøre det, og hvorfor. Vis at du ser hele pasienten, prioriterer tiltak og samarbeider med andre.

Eksempelsvar

Innledning

Bjørg er 78 år og er innlagt på sykehjem etter hoftebrudd. Hun har KOLS, røyker og har nylig hatt en infeksjon i nedre luftveier. Hun er i gang med rehabilitering, men blir fort andpusten når hun mobiliseres, og hun er redd for å falle igjen. Før bodde hun hjemme med hjemmesykepleie to ganger daglig, og datteren er usikker på om moren kan flytte hjem. Målet med tiltaksplanen er at Bjørg skal trene trygt, få pusten til å fungere best mulig, bli mindre redd for å falle og være med å planlegge veien videre.

Hoveddel

Det første jeg prioriterer, er å følge med på pusten. Hun har KOLS og har nylig hatt en luftveisinfeksjon, så det er fare for at pusten kan bli verre. Jeg observerer hvor fort og tungt hun puster, hudfarge, hoste og slim, og om hun virker mer sliten eller forvirret. Hvis det er rutine, kan jeg måle oksygenmetning og temperatur. Forverring melder jeg til sykepleier med en gang. Jeg sørger for at hun sitter godt med hevet hodeende, fordi det gjør det lettere å puste.

Det andre er trening etter planen fra fysioterapeuten. Jeg passer på at hun har fått smertestillende i god tid før trening, slik sykepleier har planlagt, fordi smerter gjør at hun ikke tør eller orker å bevege seg. Vi trapper opp gradvis, fra sengekanten til stolen og korte turer med gåstol. Før vi går, minner jeg henne på leppepust, det vil si å puste ut gjennom sammenknepne lepper, som hun kan ha lært av fysioterapeuten. Det hjelper henne å få kontroll over pusten. Vi tar pauser når hun blir andpusten, og jeg går tett ved siden av henne. Når hun opplever at hun klarer mer enn hun trodde, blir hun tryggere.

Det tredje er å ta fallredselen på alvor. Jeg spør henne hva hun er redd for, og jeg lytter. Jeg forklarer at vi går trygt, at jeg er der, og at styrken hennes kommer tilbake med trening. Fallredsel kan føre til at hun beveger seg mindre, og da

blir hun svakere og faller lettere. Derfor er det like viktig å støtte henne psykisk som fysisk. Jeg sørger også for at rommet er ryddig, at hun har gode sko og at ringesnoren er innen rekkevidde.

Jeg følger også med på andre ting som kan forsinke rehabiliteringen. Jeg oppfordrer henne til å drikke, fordi det gjør slimet lettere å hoste opp. Jeg legger til rette for næringsrik mat, fordi KOLS og infeksjon tærer på kreftene. Når hun ligger mye, sørger jeg for stillingsendring og ser etter trykksår. Røykingen er et tema som sykepleier og lege tar opp med henne. Jeg kan lytte hvis hun vil snakke om det, og jeg minner om at det er forbudt å røyke nær oksygen hvis hun får det.

Når det gjelder hjemreisen, spør jeg Bjørg hva hun selv ønsker, og om hun vil at datteren skal få informasjon og være med på møter. Pasient- og brukerrettighetsloven gir henne rett til å medvirke, og jeg har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Med hennes samtykke kan datteren være med på et samarbeidsmøte med sykepleier, fysioterapeut og hjemmesykepleien. Da kan de sammen vurdere hva hun trenger for å klare seg hjemme.

Jeg dokumenterer pust, smerte, hvor langt hun gikk og hvordan hun hadde det, og gir rapport. Jeg evaluerer ved å se om hun går lenger med mindre tungpust, om smertene er under kontroll, om hun virker mindre redd og om planen for hjemreise blir tydeligere.

Avslutning

Tiltaksplanen ser hele Bjørg: hoftebruddet, KOLS, fallredselen og spørsmålet om hjemreise. Jeg prioriterer pusten og trygg trening, støtter henne psykisk og samarbeider med sykepleier, fysioterapeut og datteren når Bjørg samtykker. Slik får hun best mulig grunnlag for å bli sterkere og ta et valg om veien videre.

Øvingscase: Marit (diabetes og etisk dilemma)

Øvingscase (oppfølging + etikk/lovverk)

Case / situasjon

Sted: Hjemmesykepleien

Pasient: Marit, 78 år, bor hjemme.

Bakgrunn: Nylig fått påvist diabetes type 2. Usikker på kostholdet, gruer seg til å stikke seg med insulin og spør om hjelp. Datteren har bedt om at du ikke informerer moren om alvorlige funn, fordi hun «ikke orker å høre om det».

Diagnoser: Diabetes type 2.

Oppgave 1

Beskriv hvordan du vil følge opp Marit, og begrunn tiltakene dine. Drøft hvordan du håndterer situasjonen med datteren, og vis hvilke lover og regler som er relevante.

Eksempelsvar

Innledning

Marit er 78 år, bor hjemme og har nylig fått diabetes type 2. Hun er usikker på kostholdet, gruer seg til å sette insulin og spør om hjelp. Datteren har bedt meg om ikke å fortelle moren om alvorlige funn, fordi hun «ikke orker å høre om det». I denne oppgaven beskriver jeg hvordan jeg følger opp Marit, og jeg drøfter hvordan jeg håndterer datterens ønske ut fra lover og regler.

Hoveddel

Først bygger jeg tillit. Jeg spør Marit hvordan hun har det med den nye diagnosen, hva hun vet om diabetes og hva hun er mest redd for. Det er lettere å hjelpe når jeg vet hvor hun står. Det viser også at jeg tar henne på alvor.

Når det gjelder kostholdet, gir jeg enkle og praktiske råd. Jeg forklarer at regelmessige måltider gir jevnere blodsukker, og at grove kornprodukter, grønnsaker, fisk og magre meieriprodukter er gode valg. Søte drikker og mye sukker bør begrenses. Jeg tar utgangspunkt i det hun liker å spise, slik at endringene blir realistiske. Hvis hun trenger mer hjelp, melder jeg til sykepleier, som kan vurdere kontakt med fastlegen eller et diabeteskurs.

Marit gruer seg til insulin. Opplæringen gjøres etter prosedyre og plan fra sykepleier og lege. Jeg forklarer rolig hva som skal skje, viser utstyret og lar henne kjenne på pennen. Jeg forteller at nålene er tynne og at det for de fleste gjør lite vondt. Hun får øve i sitt eget tempo. Når hun skjønner hva hun gjør, blir hun mindre redd og kan etter hvert mestre det selv. Det er viktig, fordi frykt kan føre til at hun ikke tar insulinen. Jeg forklarer også tegn på lavt blodsukker, som svette, skjelving og uro, og hva hun skal gjøre da. Jeg observerer tegn på høyt eller lavt blodsukker, og dokumenterer hva vi har gått gjennom og hvordan hun mestrer det.

Datterens ønske er et etisk dilemma. Datteren vil beskytte moren, og det er forståelig. Men pasient- og brukerrettighetsloven sier at Marit som hovedregel har rett til informasjon om sin egen helse. Hun trenger informasjon for å kunne ta valg og medvirke i behandlingen. Det er bare i helt spesielle tilfeller at informasjon kan holdes tilbake,

og det er ikke noe jeg kan bestemme, og heller ikke noe datteren kan bestemme. Jeg kan derfor ikke love datteren å holde ting skjult.

Samtidig har jeg taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det betyr at jeg ikke kan dele opplysninger om Marit med datteren uten at Marit samtykker. Jeg svarer datteren vennlig og forklarer reglene. Jeg viser forståelse for bekymringen og sier at informasjon kan gis på en skånsom måte. Så tar jeg saken opp med sykepleier, som har ansvar for videre oppfølging.

Det beste er å spørre Marit hvordan hun vil ha det. Hun kan si at hun vil ha datteren med, eller at hun ikke ønsker å vite alle detaljer. Det er hennes valg. Hvis hun ønsker det, kan vi ha en felles samtale med datteren, sykepleier og eventuelt fastlegen. Da kan datteren få en rolle som støtte, i stedet for å bestemme på vegne av moren.

Avslutning

Oppfølgingen av Marit handler om å gi henne kunnskap og mestring i kosthold og insulinbruk, slik at hun kan leve godt med diabetes. Datterens ønske møter jeg med forståelse, men Marits rett til informasjon og taushetsplikten går foran. Ved å involvere Marit i valgene og trekke inn sykepleier, ivaretar jeg både lovverket og relasjonen til familien.